

Enkoprezis / Fekal İnkontinans

Fonksiyonel kabızlığa bağlı retansiyonel fekal inkontinansa impaksiyon boşaltımı, dozlu idame, tuvalet eğitimi ve psikososyal yönetimin basamaklı algoritması.

Rome IV

Fekal impaksiyon

PEG 3350

Tuvalet eğitimi

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Enkoprezis, gelişimsel olarak tuvalet kontrolü beklenen yaştaki (≥ 4 yaş) çocukta uygunsuz yerlere yineleyen dışkı kaçırmasıdır. Olguların ~%80-95'i retansiyonel (fonksiyonel kabızlık + rektal impaksiyon + taşma inkontinansı) kökenlidir; retansiyonel olmayan (non-retentif) alt tip normal kolon transitisi ve impaksiyon yokluğu ile ayrılır. Rome IV'e göre fonksiyonel kabızlık tanısı için ≥ 1 ay boyunca ≥ 2 kriter (haftada ≤ 2 dışkılama, haftada ≥ 1 inkontinans epizodu, retansiyon postürü, ağrılı/sert dışkı, geniş çaplı dışkı, rektal fekal kitle) gereklidir.

Öykü

- Dışkılama sıklığı, kıvamı (Bristol), çap; retansiyon postürü, kaçırmama paterni (gündüz/gece, sürekli sızma vs. tam boşaltım)
- Semptom başlangıç yaşı, tuvalet eğitimi öyküsü, ağrılı defekasyon/anal fissür, dışkı tutma davranışı
- Mekonyum pasajı zamanı (>48 sa Hirschsprung şüphesi), diyet-lif-sıvı alımı, kilo-boy seyri
- İlaç (opioid, antikolinergik), idrar inkontinansı/tekrarlayan İYE, psikososyal stresörler, aile öyküsü
- Alarm sorgusu: kanlı dışkı, kilo kaybı, kusma, karın distansiyonu, ateş

Fizik muayene

- Karın palpasyonu: sol alt kadranda/suprapubik fekal kitle; distansiyon
- Perianal inspeksiyon: fissür, anal pozisyon (anterior anüs), dermatit, dışkı bulaşı
- Lumbosakral bölge: kılınma, gamze, kitle, gluteal yarık asimetrisi (spinal disrafizm)
- Nörolojik: alt ekstremiteler tonus/refleks, kremaster ve anal ("wink") refleksi, yürüyüş
- Rektal tuşe (seçili olgu): sfinkter tonusu, ampullada dışkı; Hirschsprung'da boş/dar rektum + patlayıcı boşalma

Non-retentif fekal inkontinans tanısı ancak impaksiyon dışlandıktan sonra konur; çoğu "kaçıran" çocukta altta yatan neden aşırı dolu rektumdan taşmadır.

Kaçırma davranışının kaynağını ayırt etmek tedaviyi belirler: retansiyonel taşma en sık senaryodur, ancak organik ve non-retentif nedenler dışlanmalıdır.

Retansiyonel / taşma (en sık)

- Ağrılı defekasyon -> tutma -> rektal distansiyon -> duyu azalması
- İmpakte kitle çevresinden sıvı dışkı sızması
- Kısır döngü: rektal dilatasyon ve akkomodasyon

Non-retentif inkontinans

- Kabızlık/impaksiyon YOK, normal transit
- Sıklıkla davranışsal/emosyonel bileşen
- Tanı Rome IV ile; laksatif yanıtı

Anatomik / anorektal

- Anterior yerleşimli anüs, anal stenoz
- Anorektal malformasyon postop
- Perianal fissür kaynaklı ağrı-tutma

Nörojenik

- Spinal disrafizm / gergin kord, sakral agenezi
- Serebral palsy, myelomeningosel
- Sfinkter/pelvik taban innervasyon defekti

Motilite / enterik nöropati

- Hirschsprung hastalığı (kısa/ultrakısa segment)
- Kolonik inersi, kronik intestinal psödoobstrüksiyon
- Mekonyum pasaj gecikmesi öyküsü

Metabolik / sistemik

- Hipotiroidi, hiperkalsemi, çölyak
- Kistik fibrozis, DM
- Kurşun intoksikasyonu, inek sütü proteini ilişkili

03 Karar akışı

İlk kritik ayırım, palpabl/görüntülemeyle doğrulanan fekal impaksiyon varlığıdır; disimpaksiyon yapılmadan başlatılan idame tedavisi başarısızlıkla sonuçlanır.

BAŞLANGIÇ

>=4 yaş çocukta yineleyen dışkı kaçırma

Öykü + muayene ile retansiyonel/organik/non-retentif ayrımı yap.

ADIM 1

Alarm bulgularını tara

Bölüm 05 kırmızı bayrakları değerlendir.

KARAR 1

Alarm bulgusu var mı?

Organik hastalık işaretleri.

EVET → organik yönelim

HAYIR → fonksiyonel yol

HEDEFLİ TETKİK

Nedene yönelik incelemeyi başlat

Hirschsprung şüphesinde rektal biyopsi + anorektal manometri; spinal bulguda lumbosakral MRG; sistemik tarama (TSH, Ca, çölyak).

İMPAKSİYON VAR → önce boşalt

DİSİMPAKSİYON

Oral PEG 3350 1-1.5 g/kg/gün, 3-6 gün

Başarısız/tolere edilemezse rektal enema.
Boşalma doğrulandıktan sonra idameye geç.

KARAR 2

Fekal impaksiyon var mı?

Palpabl abdominal/rektal kitle veya karın grafisinde belirgin dışkı yükü.

İMPAKSİYON YOK → doğrudan idame

İDAME

PEG 3350 0.4-0.8 g/kg/gün + tuvalet eğitimi

Yumuşak günlük dışkı hedefi; en az 2 ay ve son normalleşmeden >=1 ay sonrasına dek sürdür, kademeli azalt.

KARAR 3

Yeterli laksatif + davranışsal tedaviye yanıt var mı?

2-4 haftada dışkılama düzeni ve kaçırma değerlendir.

EVET → sürdür ve azalt

İZLEM

Doz titrasyonu, relaps önleme

Bölüm 07 ilkeleri; erken kesme relaps riskini artırır.

HAYIR → dirençli olgu

YENİDEN DEĞERLENDİR

Uyum, doz yetersizliği, organik neden

Kolon transit çalışması, anorektal manometri; adjuvan laksatif ekle; psikoloji desteği; refrakter olguda pelvik taban biofeedback / antegrad enema (ACE) düşün.

Tipik fonksiyonel olguda tanı klinik olup rutin laboratuvar/radyoloji gereksizdir; tetkikler alarm bulgusu, atipik seyir veya tedavi direnci varlığında basamaklı istenir.

Enkoprezis/fekal inkontinansta basamaklı tetkik yaklaşımı		
BASAMAK	ENDİKASYON / EŞİK	YORUM
Klinik değerlendirme	Tüm olgular	Rome IV kriterleri + muayene; tipik fonksiyonel olguda ek tetkik gerekmez
Ayakta direkt karın grafisi	Rektal muayene yapılamayan/güvenilmeyen olguda impaksiyon şüphesi	Rutin değil; fekal yükü destekler ama tek başına tanısal değil
Sistemik laboratuvar	Büyüme geriliği, dirençli veya atipik seyir	TSH-sT4, Ca, çölyak serolojisi (doku transglutaminaz IgA + total IgA)
Kolon transit çalışması	Retentif/non-retentif ayrımı belirsiz; tedaviye dirençli	Radyoopak markör ile; kolonik inersi vs. hızlı transit ayrımı
Anorektal manometri	Hirschsprung şüphesi, rektoanal inhibitör refleks (RAIR) değerlendirmesi	RAIR yokluğu Hirschsprung düşündürür; biofeedback adayını belirler
Rektal emme biyopsisi	Manometride RAIR yok / güçlü Hirschsprung şüphesi (mekonyum gecikmesi, erken başlangıç)	Aganglioneoz için altın standart; asetilkolinesteraz boyaması
Lumbosakral spinal MRG	Nörolojik bulgu, sakral gamze/kıllanma, anormal anal tonus	Gergin kord / spinal disrafizm dışlanması

Aşağıdaki bulgular organik etiyoloji lehinedir ve fonksiyonel tedaviye başlamadan hedefli inceleme gerektirir.

- Mekonyum pasajının >48 saat gecikmesi veya yenidoğan döneminde başlangıç

- Büyüme geriliği, kilo kaybı, ateş, safralı kusma

- Karın distansiyonu + patlayıcı boşalma (Hirschsprung/enterokolit)

- Rektal kanama (fissür yokluğunda), kronik ishal

- Lumbosakral gamze, kıllanma, kitle veya gluteal asimetri

- Anormal anal tonus/pozisyon, yokluk anal veya kremaster refleksi

- Alt ekstremité güçsüzlük, DTR değişikliği, mesane disfonksiyonu

- Ekstraintestinal ipuçları: perianal fistül, aftöz ülser, artralji (IBD)

06 Tedavi (dozlu)

Dört basamak: (1) aile eğitimi/demistifikasyon, (2) fekal disimpaksiyon, (3) rekürrensi önleyen idame laksatif, (4) tuvalet eğitimi ve davranışsal destek. Oral PEG 3350 hem disimpaksiyon hem idamede birinci basamaktır.

Önce boşalt, sonra idame et: impakte rektum boşaltılmadan başlanan idame laksatif taşıma inkontinansını geçici olarak kötüleştirebilir. Aileyi kaçırmanın istemli olmadığı ve cezanın kontrendike olduğu konusunda bilgilendir.

Fekal impaksiyon boşaltımı ve idame farmakoterapisi

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
PEG 3350 — oral disimpaksiyon	1-1.5 g/kg/gün, 3-6 gün (maks 100 g/gün)
Sodyum fosfat / mineral yağ enema — rektal disimpaksiyon	1 kez/gün, 3-6 gün (yaşa göre pediatrik doz)
PEG 3350 — idame	Başlangıç 0.4 g/kg/gün; titre 0.2-0.8 g/kg/gün
Laktuloz — idame alternatifi	1-2 g/kg/gün (1-3 mL/kg/gün), 1-2 doz/gün

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
Senna — uyarıcı (2. basamak)	2-6 yaş: 2.5-5 mg/gün; 6-12 yaş: 7.5-1
Bisakodil — uyarıcı (2. basamak)	3-10 yaş: 5 mg/gün; >10 yaş: 5-10 mg
Mineral yağ (sıvı parafin) — oral	1-3 mL/kg/gün (maks ~90 mL/gün)

Aile eğitimi / demistifikasyon

Yemek sonrası tuvalet oturuşu

Ayak desteği + doğru postür

Dışkı-ödül çizelgesi

Lif + sıvı optimizasyonu

Refrakter olguda (uyum + yeterli dozda yanıtızsız) pelvik taban disfonksiyonu için biofeedback, dirençli seçilmiş olgularda antegrad kontinans enema (ACE/Malone) ve psikiyatri/psikoloji ortak yönetimi değerlendirilir.

Enkoprezis kronik seyirli ve relaps eğilimlidir; başarı, yeterli süre ve dozla idamenin sürdürülmesine ve tuvalet rutininin oturmasına bağlıdır.

İzlem takvimi ve hedefler

- Disimpaksiyon sonrası 1-2 hafta içinde erken kontrol; ardından 4-8 haftada bir
- Hedef: günde 1 ağrısız, yumuşak (Bristol 4-5) dışkı; kaçırma epizodlarının kaybolması
- Dışkı günlüğü/çizelge ile sıklık, kıvam ve kaçırma takibi
- İdameyi en az 2 ay ve semptom düzelmesinden sonra ≥ 1 ay sürdür; tuvalet eğitimi tamamlanana dek erken kesme
- Doz azaltımı kademeli; relapsta önceki etkili doza dön

Davranışsal ve psikososyal

- Yapılandırılmış tuvalet oturduğu: öğün sonrası 5-10 dk, gün 2-3 kez, ayak desteğiyle
- Cezalandırma yerine olumlu pekiştirme; suçlamayı önle
- Okul ortamına uyum (tuvalet erişimi, mahremiyet), öğretmen bilgilendirme
- Eşlik eden anksiyete/DEHB/davranış sorunlarında psikoloji-psikiyatri iş birliği
- Aileye kronik seyri ve relaps olasılığını anlat; uzun izlem beklentisi oluşturun

Yanıtsızlıkta önce en sık nedeni dışla: yetersiz doz ve tedavi uyumsuzluğu. Bunlar giderildiği hâlde yanıt yoksa organik neden ve pelvik taban disfonksiyonunu yeniden değerlendir.

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.
2. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, et al. Evaluation and Treatment of Functional Constipation in Infants and Children: ESPGHAN/NASPGHAN Evidence-Based Recommendations. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(2):258-274.
3. Koppen IJN, Lammers LA, Benninga MA, Tabbers MM. Management of Functional Constipation in Children: Therapy in Practice. Paediatr Drugs. 2015;17(5):349-360.
4. Rajindrajith S, Devanarayana NM, Benninga MA. Fecal Incontinence in Children: Epidemiology, Pathophysiology, Evaluation and Management. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;71(5):561-570.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanına yönelik klinik karar desteęi amaçlıdır; hastaya özgü deęerlendirmenin, güncel kılavuzların ve klinik muhakemenin yerini tutmaz. Dozlar ve endikasyonlar uygulama öncesi kaynaklardan ve yerel formüllerden doğrulanmalıdır.